间质性肺疾病 ★★☆（0~3题）

进行性呼吸困难、干咳少痰、Velcro 啰音 / 爆裂音、杵状指
HRCT：网格、蜂窝影等
肺功能（2010、2013、2016、2025）：限制性通气障碍（RV、TLC、FVC ↓）、弥散障碍（DLco ↓，低氧血症的主要机制）

	特发性肺纤维化（2007、2008、2009、2013、2016、2025）	结节病（2015、2017）
可能可能最可能	Velcro 啰音 / 爆裂音、杵状指	双肺门淋巴结肿大（最常见），皮肤结节性红斑、冻疮样狼疮，葡萄膜炎
重要检查	HRCT：双肺外带胸膜下、基底部分布为主	活检：支气管镜见黏膜结节呈铺路石样，非干酪性肉芽肿
治疗	肺移植：最有效 抗纤维化：尼达尼布、吡非尼酮、高剂量乙酰半胱氨酸 急性加重 —— 防控感染（但不推荐常规用） 高剂量激素（但不推荐常规用） 氧疗（但不推荐机械通气）	多不需治疗 症状严重：糖皮质激素（6~24 月） 分期：I：双肺门淋巴结肿大；II：双肺门淋巴结肿大 肺部浸润影；III：肺部浸润影；IV：蜂窝肺、肺纤维化、肺气肿

间质性肺疾病鉴别诊断（2024）

	特发性肺纤维化	结节病	过敏性肺炎（2018、2019）	肺泡蛋白沉着症 “牛奶撒了一地、吸引蝴蝶”	嗜酸性粒细胞性肺炎
BALF	中性粒、嗜酸性粒细胞↑	CD4 T 细胞↑为主	CD8 T 细胞↑为主 “不再爱过”	奶白色、稠厚、分层、PAS(+)	嗜酸性粒细胞明显↑
影像学	双肺外带 胸膜下、基底部分布为主	双肺门淋巴结肿大 沿支气管血管束分布的结节	磨玻璃斑片影的马赛克征 “对马赛克过敏”	地图样（磨玻璃影与正常组织截然分开） 铺路石样、蝴蝶样（肺门周围的肺泡渗出）	肺水肿反转形状
其他			①根本措施：避免接触抗原（鸽子等） ②糖皮质激素	低氧血症的主要机制：肺内分流 治疗：全肺灌洗	治疗：糖皮质激素